

TD QCD/QCM — Appendicite, occlusions, péritonites

INFAS

Institut National de Formation des Agents de Santé

Unité Pédagogique d'Anatomie, Physiologie et de Chirurgie

TRAVAUX DIRIGÉS • EXERCICES D'APPLICATION

Pathologies Chirurgicales

Digestives

Appendicite Aiguë • Occlusions Intestinales Aiguës • Péritonites

CHAPITRE 1 Appendicite Aiguë

CHAPITRE 2 Occlusions Intestinales Aiguës

CHAPITRE 3 Péritonites

Sciences Infirmières — Licence 2 (L2)

Questions à Choix Double (QCD) et Questions à Choix Multiple (QCM)

DOCUMENT D'EXERCICES — SANS CORRIGÉ

SOMMAIRE

Chapitre 1 — Appendicite Aiguë

Objectifs

Questions à Choix Double (QCD) — 15 items

Questions à Choix Multiple (QCM) — 15 items

Chapitre 2 — Occlusions Intestinales Aiguës

Objectifs

Questions à Choix Double (QCD) — 15 items

Questions à Choix Multiple (QCM) — 15 items

Chapitre 3 — Péritonites

Objectifs

Questions à Choix Double (QCD) — 15 items

Questions à Choix Multiple (QCM) — 15 items

CHAPITRE 1 — APPENDICITE AIGUË

OBJECTIFS

%^a DÉFINIR l'appendicite aiguë

%^a CITER trois formes anatomopathologiques de l'appendicite aiguë

%^a CITER trois signes fonctionnels et deux signes physiques de l'appendicite aiguë

%^a ÉNUMÉRER trois complications évolutives de l'appendicite aiguë

%^a PROPOSER un traitement des appendicites aiguës et de leurs formes compliquées

%^a DÉCRIRE les principales interventions infirmières péri-opératoires chez un patient appendicectomisé

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) — Vrai ou Faux

Consigne : pour chaque proposition, cochez la case VRAI ou FAUX correspondante.

N°

Proposition

VRAI

FAUX

1

L'appendicite aiguë représente l'urgence abdominale la plus fréquente.

2

Elle est particulièrement fréquente chez le nourrisson de moins de 3 ans.

3

Son pic de fréquence se situe entre 10 et 30 ans.

4

Il existe un parallélisme anatomoclinique constant dans l'appendicite aiguë, ce qui rend le diagnostic aisé.

5

L'appendice est un diverticule intestinal borgne contenant du tissu lymphoïde, et mesure habituellement 8 à 10 cm.

6

La voie hématogène est le mode de contamination habituel de l'appendice.

7

On distingue trois formes anatomopathologiques de l'appendicite : catarrhale, phlegmoneuse et gangreneuse.

8

La diarrhée est un signe fréquent dans la forme typique de l'appendicite aiguë de l'adulte jeune.

9

Le toucher rectal réveille une douleur du cul-de-sac de Douglas en cas d'appendicite aiguë.

10

La NFS montre habituellement une hyperleucocytose supérieure à 10 000 éléments/mm³ à polynucléaires neutrophiles.

11

L'échographie abdominale évoque le diagnostic devant un épaississement de la paroi appendiculaire inférieur à 8 mm.

12

La tomодensitométrie abdominale est l'examen d'imagerie de référence pour le diagnostic de l'appendicite aiguë.

13

L'appendicite toxique est une forme bénigne, sans retentissement sur l'état général.

14

Le traitement du plastron appendiculaire est chirurgical d'emblée, sans phase médicale préalable.

15

Chez la femme enceinte, l'appendicectomie est encadrée d'un traitement tocolytique.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

Consigne : pour chaque question, cochez la seule réponse exacte parmi les propositions A, B, C et D.

1. Quel est le pic de fréquence de l'appendicite aiguë ?

A. Avant 3 ans

B. Entre 10 et 30 ans

C. Entre 40 et 60 ans

D. Après 70 ans

2. Quelle est la longueur habituelle de l'appendice ?

A. 2 à 4 cm

B. 4 à 6 cm

C. 8 à 10 cm

D. 12 à 15 cm

3. Quelle est la voie de contamination habituelle de l'appendice ?

A. Voie hématogène

B. Voie lymphatique exclusive

C. Voie transplacentaire

D. Voie endogène

4. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est PAS une cause de contamination de l'appendice par voie endogène ?

A. Décharge bacillémique liée à une septicémie

B. Stercolithe

C. Hyperplasie du tissu lymphoïde

D. Corps étranger

5. Combien de formes anatomopathologiques d'appendicite aiguë sont classiquement décrites ?

A. Deux

B. Trois

C. Quatre

D. Cinq

6. Laquelle des propositions suivantes NE fait PAS partie des formes anatomopathologiques de l'appendicite ?

A. Catarrhale

B. Phlegmoneuse

C. Ulcéreuse

D. Gangreneuse

7. Dans la forme typique de l'appendicite aiguë, la température se situe habituellement entre :

A. 36° et 37°

B. 39,5° et 40°

C. 37° et 37,5°

D. 38° et 38,5°

8. Quel signe physique est classiquement recherché à l'inspection de la fosse iliaque droite en cas d'appendicite aiguë ?

A. Une diminution de l'amplitude des mouvements respiratoires

B. Une augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires

C. Un météorisme majeur

D. Une cicatrice

9. Le toucher rectal, en cas d'appendicite aiguë typique, retrouve typiquement :

A. Une ampoule rectale vide et indolore

- B. Une douleur du cul-de-sac de Douglas
 - C. Un fécalome
 - D. Une masse dure et indolore
10. Le seuil d'hyperleucocytose habituellement retenu à la NFS en cas d'appendicite aiguë est :
- A. Supérieur à 5 000 éléments/mm³
 - B. Supérieur à 15 000 éléments/mm³
 - C. Supérieur à 10 000 éléments/mm³
 - D. Supérieur à 8 000 éléments/mm³
11. Quel examen d'imagerie est considéré comme l'examen de référence pour le diagnostic de l'appendicite aiguë ?
- A. L'abdomen sans préparation (ASP)
 - B. La tomodensitométrie abdominale
 - C. L'échographie abdominale
 - D. Le lavement baryté
12. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une forme grave d'emblée de l'appendicite aiguë ?
- A. L'appendicite toxique
 - B. L'appendicite rétrocaecale
 - C. L'appendicite mésocœliaque
 - D. L'appendicite herniaire
13. Devant une douleur de la fosse iliaque droite chez la femme, quel diagnostic différentiel chirurgical doit être évoqué en priorité ?
- A. La cystite
 - B. La grossesse extra-utérine droite
 - C. La gastrite
 - D. La lombalgie
14. Quelle est l'indication thérapeutique en cas d'abcès appendiculaire ?
- A. Simple surveillance clinique
 - B. Antibiothérapie seule, sans geste chirurgical
 - C. Drainage suivi d'appendicectomie
 - D. Laparotomie exploratrice sans appendicectomie
15. Après une appendicectomie sans drainage, l'ablation des fils de suture se fait habituellement :
- A. Entre le 1er et le 2e jour
 - B. Entre le 10e et le 12e jour
 - C. Après le 21e jour
 - D. Entre le 5e et le 7e jour

CHAPITRE 2 — OCCLUSIONS INTESTINALES AIGÜES

OBJECTIFS

%^a DÉFINIR l'occlusion intestinale aiguë

%^a CITER les trois processus étiologiques de l'occlusion intestinale

%^a DÉCRIRE les signes fonctionnels et le signe physique du syndrome occlusif

%^a DISTINGUER les caractéristiques cliniques et radiologiques de l'occlusion du grêle et de l'occlusion colique

%^a ÉNUMÉRER les gestes de réanimation d'urgence devant une occlusion intestinale aiguë

%^a PROPOSER une conduite thérapeutique adaptée selon le mécanisme de l'occlusion

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) — Vrai ou Faux

Consigne : pour chaque proposition, cochez la case VRAI ou FAUX correspondante.

N°

Proposition

VRAI

FAUX

1

L'occlusion intestinale aiguë correspond à un arrêt complet et persistant du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal donné.

2

Toute occlusion intestinale est une affection grave nécessitant une thérapeutique urgente associant réanimation médicale et geste chirurgical.

3

Les occlusions intestinales relèvent d'un seul et même mécanisme physiopathologique.

4

La strangulation se caractérise par des lésions vasculaires pouvant conduire à la nécrose puis à la perforation de l'anse intestinale.

5

Le volvulus correspond à l'incarcération d'une anse intestinale dans un orifice interne de la cavité abdominale.

6

Une hypokaliémie peut être à l'origine d'une occlusion fonctionnelle.

7

Dans le syndrome occlusif, la contracture abdominale à la palpation est un signe constant.

8

L'arrêt des matières et des gaz constitue le signe fonctionnel majeur de l'occlusion, bien qu'il puisse être difficile à préciser cliniquement.

9

L'image hydroaérique retrouvée sur l'abdomen sans préparation est le signe radiologique essentiel de l'occlusion intestinale.

10

L'hématocrite est habituellement abaissé au cours de l'occlusion intestinale du fait de l'hypovolémie.

11

Dans l'occlusion du grêle, les vomissements sont précoces et abondants, contrairement à l'occlusion colique où ils sont tardifs et rares.

12

Dans l'occlusion colique, l'état général est rapidement et sévèrement altéré dès le début des symptômes.

13

La pose d'une sonde urinaire à demeure n'est pas indiquée dans la prise en charge initiale d'une occlusion intestinale.

14

En cas de volvulus avec anse intestinale saine, le traitement consiste à réintégrer et fixer l'anse.

15

Le pronostic des reprises chirurgicales pour occlusion post-opératoire est habituellement favorable, indépendamment de l'âge du patient.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

Consigne : pour chaque question, cochez la seule réponse exacte parmi les propositions A, B, C et D.

1. L'occlusion intestinale aiguë se définit comme :

- A. Un ralentissement transitoire du transit intestinal
- B. Un arrêt complet et persistant du transit des matières et des gaz
- C. Une accélération du transit intestinal
- D. Une distension abdominale isolée sans trouble du transit

2. Parmi les mécanismes suivants, lequel correspond à une occlusion par strangulation ?

- A. Une tumeur sténosante de la paroi intestinale
- B. Un fécalome
- C. Un volvulus
- D. Une compression extrinsèque par une bride sans torsion vasculaire

3. Quelle est la cause la plus fréquente d'occlusion mécanique par obturation de la lumière intestinale ?

- A. Un bézoard
- B. Un fécalome
- C. Un calcul biliaire migré (iléus biliaire)
- D. Toutes ces réponses peuvent être en cause

4. Les occlusions fonctionnelles résultent essentiellement :

- A. D'un dérèglement du système nerveux intestinal
- B. D'un obstacle anatomique fixe
- C. D'une tumeur colique sténosante
- D. D'une invagination intestinale

5. Parmi les signes fonctionnels du syndrome occlusif, lequel est considéré comme le signe majeur définissant l'occlusion ?

- A. Les douleurs abdominales
- B. L'arrêt des matières et des gaz
- C. Les vomissements
- D. Le météorisme

6. À la palpation de l'abdomen en cas d'occlusion intestinale, on retrouve classiquement :

- A. Une contracture généralisée
- B. Une défense localisée systématique
- C. Une paroi souple ou tendue, élastique et douloureuse, sans contracture
- D. Un ventre de bois

7. Parmi les anomalies suivantes, laquelle n'est PAS habituellement retrouvée au cours de l'occlusion intestinale ?

- A. Hyperleucocytose
- B. Hyperazotémie
- C. Hypokaliémie

D. Hématocrite abaissé

8. Le signe radiologique essentiel affirmant le diagnostic d'occlusion intestinale sur l'abdomen sans préparation est :

A. L'image hydroaérique

B. Le pneumopéritoine

C. La grisaille diffuse

D. Le calcul radio-opaque

9. Dans l'occlusion du grêle, les images hydroaériques à l'ASP sont typiquement :

A. Périphériques et peu nombreuses

B. Centrales, multiples, plus hautes que larges

C. Absentes

D. Uniquement coliques

10. Dans l'occlusion colique, le météorisme :

A. Tardif et discret

B. Localisé exclusivement à l'épigastre

C. Précoce, important, et dessine volontiers le cadre colique

D. Absent

11. Devant une occlusion par strangulation, la période préopératoire de réanimation doit être :

A. Prolongée de plusieurs jours

B. Inutile

C. Retardée jusqu'à normalisation complète de l'ionogramme

D. Brève

12. Le premier geste de réanimation à réaliser devant une occlusion intestinale aiguë est :

A. La mise en place d'une sonde gastro-duodénale en aspiration et d'une perfusion avec bilan biologique

B. L'antibiothérapie systématique

C. La laparotomie immédiate

D. Le lavement baryté

13. En cas de volvulus du côlon avec anse sphacélée, le traitement consiste en :

A. Une simple détorsion sans résection

B. Une résection colique

C. Une surveillance simple

D. Un lavement évacuateur

14. Devant une occlusion par foyer septique circonscrit (cholécystite), le traitement peut se limiter à :

A. La chirurgie d'emblée

B. Une simple surveillance sans traitement

C. L'antibiothérapie et la réanimation

D. Le lavement baryté seul

15. Le pronostic des occlusions post-opératoires nécessitant une reprise chirurgicale est :

A. Toujours excellent

B. Sans rapport avec l'âge du patient

C. Meilleur que celui des occlusions non opérées

D. Mauvais, d'autant plus péjoratif que le patient est âgé

CHAPITRE 3 — PÉRITONITES

OBJECTIFS

%^a DÉFINIR la péritonite

%^a CITER les principales étiologies de la péritonite

%^a DÉCRIRE les deux périodes cliniques de la péritonite aiguë diffuse

%^a CITER les différents types anatomocliniques de péritonite

%^a ÉNUMÉRER les examens complémentaires du bilan préopératoire d'une péritonite

%^a DÉCRIRE les interventions infirmières pré- et post-opératoires chez un patient présentant une péritonite

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) — Vrai ou Faux

Consigne : pour chaque proposition, cochez la case VRAI ou FAUX correspondante.

N°

Proposition

VRAI

FAUX

1

La péritonite est une inflammation de la cavité péritonéale, habituellement d'origine bactérienne.

2

Les micro-organismes responsables d'une péritonite proviennent exclusivement d'une contamination externe par blessure.

3

Seule l'appendicite rompue peut être à l'origine d'une péritonite, les autres pathologies digestives n'étant jamais en cause.

4

Les péritonites aiguës diffuses constituent une urgence abdominale mettant en danger immédiat la vie du malade.

5

Dans la période initiale de la péritonite aiguë diffuse, on observe habituellement un relâchement de la paroi abdominale à la palpation.

6

Le pneumopéritoine se traduit radiologiquement par un croissant gazeux interhépatophrénique visible en position verticale.

7

À la période terminale de la péritonite, les vomissements ont tendance à disparaître progressivement.

8

À la période terminale, la contracture abdominale initiale fait place à une tension marquée du ventre.

9

La péritonite tuberculeuse touche exclusivement la femme et n'atteint jamais l'homme.

10

La péritonite encapsulante se caractérise par la présence de kystes hydatiques multiples dans la cavité péritonéale.

11

Le traitement de l'échinococcose péritonéale est uniquement chirurgical.

12

Sur le plan physiopathologique, le liquide initialement déversé dans la cavité abdominale est stérile avant d'être contaminé par des bactéries en quelques heures.

13

Au cours de la péritonite, le péristaltisme intestinal reste augmenté durant toute l'évolution de la maladie.

14

Le bilan préopératoire d'une péritonite comprend notamment la NFS, l'urée, la créatininémie, le groupe sanguin-Rhésus, l'ECG et la radiographie pulmonaire.

15

La laparotomie est l'intervention chirurgicale de choix dans le traitement de la péritonite.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

Consigne : pour chaque question, cochez la seule réponse exacte parmi les propositions A, B, C et D.

1. La péritonite se définit comme :

- A. Une inflammation de la muqueuse gastrique
- B. Une inflammation de la cavité péritonéale, habituellement d'origine bactérienne
- C. Une inflammation isolée du mésentère sans atteinte péritonéale
- D. Une accumulation stérile de liquide péritonéal sans inflammation

2. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne figure PAS parmi les causes courantes de péritonite ?

- A. La cholécystite aiguë
- B. La pancréatite aiguë
- C. La migraine chronique
- D. La salpingite

3. Les péritonites aiguës diffuses sont considérées comme :

- A. Une pathologie bénigne ne nécessitant pas d'hospitalisation
- B. Une affection exclusivement chronique
- C. Une contre-indication à la chirurgie
- D. Une urgence abdominale mettant en danger immédiat la vie du malade

4. À la période initiale de la péritonite aiguë diffuse, l'examen de l'abdomen révèle typiquement :

- A. Une immobilité diaphragmatique et une contracture abdominale
- B. Un abdomen souple et indolore
- C. Un météorisme majeur isolé sans douleur
- D. Une matité déclive isolée

5. Le signe radiologique évocateur d'une perforation digestive au cours d'une péritonite est :

- A. L'image hydroaérique
- B. Le pneumopéritoine (croissant gazeux interhépatophrénique)
- C. La cocarde barytée
- D. Le niveau liquide colique

6. À la période terminale de la péritonite non traitée, les vomissements deviennent :

- A. Absents
- B. Uniquement alimentaires

- C. Incessants, bilieux puis porracés puis fécaloïdes
 - D. Hémorragiques exclusivement
7. Les péritonites localisées peuvent notamment se présenter sous la forme :
- A. D'un abcès sous-phrénique
 - B. D'un abcès appendiculaire
 - C. D'une pelvi-péritonite génitale
 - D. Toutes ces réponses sont exactes
8. La péritonite tuberculeuse, forme de péritonite chronique, est :
- A. Plus fréquente chez la femme que chez l'homme
 - B. Plus fréquente chez l'homme que chez la femme
 - C. Strictement limitée à l'enfant
 - D. Sans lien avec l'état général du patient
9. Parmi les causes prédisposantes de la péritonite tuberculeuse figurent :
- A. L'hypertension artérielle
 - B. La grossesse, l'accouchement et l'alcoolisme
 - C. Le diabète de type 1 exclusivement
 - D. La vaccination BCG récente
10. La péritonite encapsulante se caractérise par :
- A. Des kystes hydatiques multiples
 - B. Une ascite chyleuse isolée
 - C. Une membrane blanche et nacréée englobant tout ou partie de l'intestin grêle
 - D. Une perforation digestive aiguë
11. L'échinococcose péritonéale résulte le plus souvent de :
- A. Une infection bactérienne banale
 - B. Une tuberculose péritonéale évoluée
 - C. Une complication d'appendicite
 - D. La rupture d'un kyste hydatique primitif, notamment hépatique
12. Sur le plan physiopathologique, le liquide qui s'écoule initialement dans la cavité abdominale au cours d'une péritonite est :
- A. Stérile avant de se contaminer en quelques heures
 - B. Déjà fortement contaminé par des bactéries
 - C. Toujours hémorragique
 - D. Composé uniquement de bile
13. Le tube digestif réagit à la péritonite par :
- A. Un arrêt immédiat et définitif du péristaltisme
 - B. Une hypermobilité initiale suivie d'un iléus paralytique
 - C. Une accélération permanente du transit
 - D. Aucune modification du péristaltisme
14. Le bilan préopératoire recommandé devant une péritonite comprend notamment :
- A. Uniquement une échographie abdominale
 - B. Un lavement baryté systématique
 - C. La NFS, l'urée, la créatininémie, le groupe sanguin-Rhésus, l'ECG et la radiographie pulmonaire

D. Une coloscopie totale

15. Le traitement chirurgical de référence de la péritonite est :

A. La coelioscopie exploratrice seule, sans lavage

B. La simple ponction évacuatrice sous échographie

C. L'abstention chirurgicale avec antibiothérapie seule

D. La laparotomie, permettant traitement de la cause, prélèvement bactériologique, lavage et drainage